论著·外治理论与应用

浮针联合综合康复训练治疗气虚血瘀型脑卒中后失语症临床观察

周睿恒,王 彬,王 杨,彭全成

(湖北省第三人民医院,湖北 武汉 430033)

[摘要] 目的:探究浮针疗法联合综合康复训练治疗气虚血瘀型脑卒中后失语症的疗效及其对患者神经功能的影响。方法:选气虚血瘀型脑卒中后失语症患者80例为研究对象,以随机数字表法分为观察组、对照组各40例。对照组接受综合康复训练治疗,观察组在此基础上增加浮针治疗。比较两组患者治疗前后中医证候积分、中国式功能性语言沟通能力检查法(CFCP)评分、神经功能缺损程度评分、临床疗效及不良反应发生情况。结果:治疗后,两组患者言语謇涩、半身不遂、感觉减退积分均较治疗前降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗2个月、治疗3个月(治疗结束)、治疗结束后5个月,两组CFCP评分均较治疗前升高,神经功能缺损程度评分较治疗前下降,且观察组变化程度较对照组显著,差异有统计学意义($P<0.05$)。观察组临床疗效优于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。两组不良反应发生情况对比,差异无统计学意义($P>0.05$)。结论:浮针治疗联合综合康复训练可显著提升脑卒中后失语症患者治疗效果,改善患者临床症状、言语沟通能力及神经功能,且其安全性有一定保障。

[关键词] 浮针;综合康复训练;气虚血瘀;脑卒中;失语症;神经功能

[中图分类号] R246;R255.2 [文献标志码] A [文章编号] 0257-358X(2025)03-0315-06

DOI:10.16295/j.cnki.0257-358x.2025.03.013

Clinical Observation of Superficial Needling Combined with Comprehensive Rehabilitation Training in Treatment of Aphasia After Stroke of Qi Deficiency and Blood Stasis Type

ZHOU Ruiheng,WANG Bin,WANG Yang,PENG Quancheng

(The Third People's Hospital of Hubei Province,Wuhan 430033,China)

Abstract **Objective**:To explore the effect of superficial needling therapy combined with comprehensive rehabilitation training in the treatment of aphasia after stroke of qi deficiency and blood stasis type and its effect on the neurological function of patients. **Methods**: A total of 80 patients with aphasia after stroke of qi deficiency and blood stasis type were selected as the study subjects, and were divided

[收稿日期] 2024-11-12
[基金项目] 湖北省卫生健康委员会课题项目(编号:WJ2021M203)
[作者简介] 周睿恒,主治医师,主要从事神经康复研究。
[通信作者] 彭全成,主任医师,主要从事神经康复研究。邮箱:181262812@qq.com。

中国知网 https://www.cnki.net

into the observation group and the control group with random number table method, with 40 cases in each group. The control group received comprehensive rehabilitation training treatment, while the observation group was supplemented with superficial needling therapy. Traditional Chinese medicine (TCM) syndrome score, Chinese Functional Communication Profile (CFCP) score, level of neural-functional defect score, clinical efficacy and incidence of adverse reactions of the two groups of patients were compared before and after treatment. **Results**: After treatment, the scores of speech retardation, hemiplegia and hypoesthesia in both groups were lower than those before treatment, and the scores of the observation group were lower than those of the control group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). Treatment for two months, three months (end of treatment), five months after treatment, CFCP score increased and neural-functional defect score decreased in both groups compared with those before treatment, the degree of change in the observation group was significantly higher than that in the control group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). The clinical efficacy of the observation group was better than that of the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). There was no significant difference in the occurrence of adverse reactions between the two groups ($P>0.05$). **Conclusions**: Superficial needling therapy combined with comprehensive rehabilitation training can significantly improve the therapeutic effect of patients with aphasia after stroke, relieve the clinical symptoms, promote the verbal communication ability and neurological function, and its safety is guaranteed to some extent.

Keywords superficial needling; comprehensive rehabilitation training; qi deficiency and blood stasis; stroke; aphasia; neurological function

脑卒中后失语症是指脑卒中后患者出现语言障碍，病理机制涉及大脑多个区域和神经回路的损伤[1]。据报道，25%～30%的脑卒中患者遗留不同程度的言语功能障碍，尽管急性期脑卒中后失语症患者有一定程度的自发性恢复，但多数患者仍会遗留一定程度言语功能障碍[2]。脑卒中后失语症患者临床辨证多以气虚血瘀型最为常见[3]。脑卒中后失语可以采取语言训练、物理治疗、心理干预等方式进行康复。但康复治疗需要长时间持续训练，在年龄、家庭负担等因素影响下，治疗存在较大局限性，整体疗效难以令人满意[4]。针灸干预在脑卒中治疗中历史悠久，其在改善脑卒中后失语症患者语言功能减退及提高远期语言功能方面具有一定的优势[5]。浮针是一种充分融入现代医学观点和理论的现代针灸疗法，具有不同于传统针刺治疗的独特针具和针刺方法，以往多用于与骨骼肌系统疾病有关的躯体疼痛的治疗中，具有显著的减轻疼痛和提高运动功能的作用[6]。随着研究的不断深入，浮针疗法已日趋成熟，其应用范围不断扩大，在疼痛性疾病以外的神经系统疾病的治疗中也取得了一定效果。目前，浮针疗法应用于脑卒中后遗留语言功能障碍的研究并不多见。基于此，本研究将浮针疗法应用于气虚血瘀型脑卒中后失语症患者的康复治疗中，针对性改善气虚血瘀型脑卒中后失语症患者的语言功能，报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取湖北省第三人民医院2023年9月至2023年12月收治的脑卒中后失语症患者80例，依据随机数字表法分成对照组和观察组各40例。观察组男21例，女19例；年龄49～83岁，平均(64.50±7.20)岁；平均病程(21.40±6.19)d；脑出血、脑梗死分别有13例、27例；失语类型：运动性失语11例，听觉性失语16例，完全性失语6例，经皮质运动性失语4例，经皮质混合性失语3例。对照组男22例，女18例；年龄48～79岁，平均(63.98±7.53)岁；平均病程(22.03±6.07)d；脑出血、脑梗死分别有11例、29例；失语类型：运动性失语14例，听觉性失语12例，完全性失语6例，经皮质运动性失语5例，经皮质混合性失语3例。两组患者上述一般资料比较，差异无统计学意

中国知网 https://www.cnki.net

义（$P>0.05$），可进行后续研究指标的比较分析。本研究获湖北省第三人民医院医学伦理委员会批准通过（伦理审批号：院准-2020-10-021号）。

1.2　诊断标准

1.2.1　西医诊断标准

根据《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》制定脑卒中诊断标准[7]。急性起病、局灶性神经功能缺损（如半身不遂、言语謇涩、感觉减退变性），症状持续时间超过数小时，脑CT或MRI检查排除脑出血和其他病变，同时排除非血管性病因。

失语症诊断标准[8]：通过波士顿诊断性失语症检查（BDAE）进行严重程度分级，包括对自发言语、听理解、复述、命名、阅读和书写等语言功能的评估，计算失语指数，失语指数低于93.8即可判定存在失语症。

1.2.2　中医诊断标准

根据《中医病证诊断疗效标准》[9]确定气虚血瘀型中风诊断标准。主症：口舌歪斜，半身不遂，偏身麻木，手足肿胀，语謇失语，神识昏蒙；次症：气短乏力，面色淡白，心悸自汗，舌苔白腻或薄白，舌质晦暗或有瘀点，脉细涩或细缓。

1.3　纳入标准

①符合上述中西医诊断标准；②年龄在18周岁以上；③意识清晰，属首次发病；④脑卒中前无明显残疾；⑤预期寿命至少6个月；⑥患者或法定授权代表已签署知情同意书。

1.4　排除标准

①合并肝肾等脏器功能异常；②存在其他原因导致的语言功能异常，如发音器官损伤等；③合并恶性肿瘤；④合并造血系统或内分泌系统障碍；⑤合并智力障碍，无法配合研究；⑥存在视听功能障碍；⑦针灸不耐受；⑧癫痫发作。

2　方法

2.1　治疗方法

2.1.1　对照组治疗

实施常规基础治疗与综合康复训练，常规基础治疗参照《新编神经系统疾病诊疗指南》[10]，具体包括血压血糖控制、血脂调节、抗血小板聚集、稳定斑块、改善脑循环等。合并运动功能障碍者，联合给予运动和作业疗法，包括关节主被动活动、阻力训练、软组织拉伸和手功能训练、职业和文体训练等。同时患者接受语言康复训练，包括口唇运动、舌运动、发音、听觉刺激训练，以《中国脑性瘫痪康复指南（2015）》[11]为标准开展训练。每个项目训练均在言语康复治疗师指导下依次完成，每项训练10 min，每天重复3次，共干预60 d。①口唇运动：反复进行抿嘴、鼓腮、吹蜡烛等动作。②舌运动：由快至慢，反复进行舌外伸、舔唇及舌尖朝向四周运动。③发音：从简短发音如发唇音和发“啁”音逐渐过渡至复杂的发音，包括单音节、单词、句等，反复训练。④听觉刺激训练：在治疗师指导下完成点头、张嘴、眨眼等单一动作；15 d后由易到难加入复合句训练，让患者听取语音材料，让其回答问题或复述内容；30 d后加入语言表达和记忆训练，由护士提出主题，如礼貌用语、天气、食物等；让患者听取语音材料，参加交流会话，或背诵习惯用语等。患者结束治疗后5个月门诊随访观察。

2.1.2　观察组治疗

在对照组治疗基础上联合浮针治疗。嘱咐患者取坐位，参考《经络腧穴学》[12]选择进针点，头部取百会、脑户，背部取至阳、大椎、神道、腰阳关、腰俞穴位。进针点做好标记，常规碘伏消毒后用一次性中号浮针（南京派福医学科技有限公司）进行多靶点扫散治疗。手持进针器与皮肤呈15°～35°方向，针尖朝向患肌，快速将针体推至皮下，整个针刺过程应感觉皮肤松软容易进入，患者痛感不明显。用右手拇指和中指夹住针座，以置于皮肤上的拇指尖为支点，示指和无名指自然搭放于皮肤上，两指发力，一前一后平稳且有力地做扇形扫散动作，幅度40°左右，一个进针点扫散2～3 min，每分钟约100次。治疗结束后将枕芯取出，软套管皮下留置并用敷贴固定6～8 h，期间患者可适当活动。留管期间注意留管处保持干燥，预防感染发生；避免挤压软管，当患者有疼痛感或肢体活动受到影响时，应取出软管。浮针治疗每周2次，连续治疗3个月。患者结束治疗后5个月门诊随访观察。

2.2　观察指标

2.2.1　中医证候积分

治疗前及治疗结束后5个月，参考《中医内科学》[13]对患者临床症状进行评估，包括言语謇涩、半

中国知网　https://www.cnki.net

身不遂、感觉减退。采用4级评分法(0、2、4、6分),分为无、轻度、中度及重度,得分越高,程度越重。

2.2.2 语言功能

分别于治疗前、治疗2个月、治疗3个月(治疗结束)及治疗结束后5个月采用中国式功能性语言沟通能力检查法(CFCP)[14]评估患者语言能力。量表包括5个维度25项条目,总250分,得分与病情恢复程度成正比。

2.2.3 神经功能

参考中华神经科学会制定的相关标准,分别于治疗前、治疗2个月、治疗结束及治疗结束后5个月采用神经功能缺损程度评分标准评估患者神经功能恢复情况[15]。量表包括7个检测项目,总共15分,得分与病情恢复程度成反比。

2.2.4 不良反应

记录患者在治疗期间出现的不良反应,包括头晕、呕吐、嗜睡、低血压。

2.3 疗效标准

根据相关文献制定疗效评价标准[16],治疗后CFCP评分相比治疗前提高≥90%,为基本治愈;CFCP评分提高≥60%但<90%,为显效;CFCP评分提高≥30%但<60%,为有效;CFCP评分提高<30%,为无效。总有效率=(基本治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计数资料用例(%)表示,进行χ^2检验;符合正态分布的计量资料用$\bar{x}\pm s$表示,进行t检验。取α=0.05为检验水准。

3 结果

3.1 两组中医证候积分比较

治疗前,两组患者言语謇涩、半身不遂、感觉减退积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组言语謇涩、半身不遂、感觉减退积分均较治疗前降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3.2 两组CFCP、神经功能缺损程度评分比较

治疗前两组CFCP、神经功能缺损程度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2个月、治疗结束、治疗结束后5个月,两组CFCP评分均较治疗前上升,神经功能缺损程度评分均下降,且观察组变化程度更为显著,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3.3 两组临床疗效比较

观察组患者临床疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3.4 两组不良反应发生情况比较

两组患者不良反应发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

4 讨论

脑卒中是全球范围内导致长期残疾的主要原因之一,其中失语是脑卒中后常见的严重后遗症。气虚血瘀是脑卒中最常见的一种病机,气虚推动无力,血液运行不畅,最终导致瘀血阻滞脑络,影响语言功能[17]。针灸疗法可调和气血、疏通经络,从而改善脑卒中后失语的症状。浮针疗法是一种特殊的针灸技术,不同于传统针灸治疗,浮针疗法的治疗工具为一次性浮针针具,将针尖对准病灶,在病灶周围进针,沿皮下疏松结缔组织层行浮针,并于操作后留针,该疗法具有起效迅速、疗效持久、操作简便、适应证广泛等特点[18]。现代康复医学认为,脑卒中后失语症是由大脑皮质语言功能区受损所致,表现为语言理解、表达及阅读、书写等方面的障碍。综合康复训练包括语言训练、认知训练、吞咽训练等多种方法,旨在通过系统的训练促进患者语言功能的恢复。随着

表1 两组气虚血瘀型脑卒中后失语症患者治疗前后中医证候积分比较($\bar{x}\pm s$) 分

组别	例数	言语謇涩		半身不遂		感觉减退	
		治疗前	治疗结束后5个月	治疗前	治疗结束后5个月	治疗前	治疗结束后5个月
观察组	40	4.46±0.79	1.94±0.57*	4.51±0.52	2.01±0.52*	4.37±0.52	1.97±0.46*
对照组	40	4.44±0.81	2.89±0.65*	4.48±0.54	2.94±0.62*	4.40±0.61	2.84±0.72*
t值		0.112	−6.949	0.253	−7.275	−0.237	−6.438
P值		0.911	<0.001	0.801	<0.001	0.814	<0.001

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。

中国知网 https://www.cnki.net

表2　两组气虚血瘀型脑卒中后失语症患者治疗前后CFCP、神经功能缺损程度评分比较（$\bar{x}\pm s$）　分

组别	例数	CFCP评分			
		治疗前	治疗2个月	治疗结束	治疗结束后5个月
观察组	40	130.43±7.26	157.53±10.61*	180.03±12.19*	216.95±11.20*
对照组	40	128.70±7.54	145.45±12.43*	160.33±12.96*	181.70±10.43*
t值		1.042	4.672	7.003	14.567
P值		0.301	<0.01	<0.01	<0.01
组别	例数	神经功能缺损程度评分			
		治疗前	治疗2个月	治疗结束	治疗结束后5个月
观察组	40	13.53±2.32	10.43±1.52*	8.75±1.26*	5.10±1.08*
对照组	40	13.33±1.87	11.70±1.16*	9.58±1.15*	7.98±1.14*
t值		0.424	−4.223	−3.062	−11.555
P值		0.673	<0.01	0.003	<0.01

注：CFCP为中国式功能性语言沟通能力检查法。
与同组治疗前比较，*P<0.05。

表3　两组气虚血瘀型脑卒中后失语症患者临床疗效比较　例（占比/%）

组别	例数	基本治愈	显效	有效	无效	总有效	χ^2值	P值
观察组	40	20（50.0）	14（35.0）	4（10.0）	2（5.0）	38（95.0）	6.275	0.012
对照组	40	13（32.5）	10（25.0）	7（17.5）	10（25.0）	30（75.0）		

表4　两组气虚血瘀型脑卒中后失语症患者不良反应发生情况比较　例（占比/%）

组别	例数	头晕	呕吐	嗜睡	低血压	总发生	χ^2值	P值
观察组	40	1（2.5）	0（0）	1（2.5）	0（0）	2（5.0）	0.213	0.644
对照组	40	1（2.5）	1（2.5）	0（0）	1（2.5）	3（7.5）		

医学模式的转变和跨学科融合的发展，中医学与现代康复医学的结合成为一种趋势。浮针联合综合康复训练正是这一趋势下的产物，旨在将中医的辨证施治与现代康复理念相结合，为患者提供更为全面和个性化的治疗方案。

本研究结果显示，两组患者的中医证候积分均得到明显改善，但观察组各项症状改善程度更明显，且临床疗效优于对照组。由此可见，浮针联合综合康复训练有利于改善脑卒中后失语症患者的言语謇涩、半身不遂等症状。分析原因可能为以下几点。①浮针疗法主要作用于疏松结缔组织，这些组织是脏腑经络之气输注出入的特殊部位。通过这种分散式治疗，浮针能够最大程度地调整经络和脏腑的气血，从而达到治疗效果。研究认为，脑卒中后的言语障碍属于中风病之中脏病，与脏腑气机紊乱密切相关，而浮针可调整疏通经络脏腑之气，有利于改善患者语言功能。②浮针作用于皮下疏松结缔组织，该组织为可产生压电和反压电效应的液晶状态，浮针扫散治疗会释放生物电，而病变组织基于疏松结缔组织所具有的高效生物电传导作用能产生反压电效应，从而可能触发大脑神经信号传递，有利于语言功能恢复。③浮针治疗以特定穴位（腧穴）作为最佳治疗点。浅刺督脉穴位，如人中、百会等，可以醒脑开窍，促进患者意识的恢复，为语言功能的恢复创造有利条件。督脉为“阳脉之海”，总督一身之阳经，具有调节全身阳经经气的作用。针刺督脉穴位，可以通调气血，改善脑部血液循环，促进受损语言功能区的修复[19-20]。浮针与综合康复训练联合应用可发挥中医针灸和现代康复医学的优势，促进脑部血液循环、调节神经系统功能和促进神经可塑性。这种综合治疗方法可以针对不同类型的失语症，如运动性失语、听觉性失语、完全性失语和经皮质运动性失语等，制定个性化的康复训练，可改善患者的语言功能和沟通能力，从而提高治疗效果。

中国知网 https://www.cnki.net

从神经功能分析，随着治疗时间的推移，两组患者CFCP评分呈上升趋势，神经功能缺损程度评分呈下降趋势，且观察组治疗2个月、治疗结束、治疗结束后5个月的得分变化程度更为显著，提示浮针联合综合康复训练在促进脑卒中后失语症患者语言功能恢复和改善神经功能损伤方面疗效确切。这种综合治疗方法有助于提高神经系统的调节能力，改善失语症状。其中浮针可以改善脑卒中后失语症患者的大脑皮层激活情况，增强语言中枢的功能，从而改善患者的语言表达能力和理解能力[21]。此外，综合康复训练中的言语训练也可以通过各种语言刺激和训练来促进脑部神经功能的恢复，进而通过多种途径促进神经系统的修复和再生，从而改善患者的言语功能和其他症状[22-23]。从安全性分析，联合干预方案的不良反应发生率较低，进一步提示浮针联合综合康复训练的可行性。

综上所述，在浮针治疗基础上联合综合康复训练治疗脑卒中后失语症疗效确切，可有效改善患者临床症状与言语沟通能力、神经功能，且其安全性有一定保障。然而，浮针联合综合康复训练促进患者语言功能恢复的相关机制目前还不十分明确，需要后续进一步开展多中心、多样本的高质量随机对照研究以深入探讨。

[参考文献]

[1] PISANO F，CALTAGIRONE C，INCOCCIA C，et al. Spinal or cortical direct current stimulation：which is the best? Evidence from apraxia of speech in post-stroke aphasia[J]. Behav Brain Res，2021，399：113019.

[2] LIEPERT J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for improving post-stroke aphasia-enough evidence for clinical routine use?[J]. Clin Neurophysiol，2022，140：165-166.

[3] 李海涛，邢玉萍. 益气活血汤联合康复训练治疗气虚血瘀型缺血性脑卒中后遗症临床观察[J]. 光明中医，2021，36(12)：1993-1996.

[4] 周厚勤，周永星，匡怡. 针刺督脉、夹脊穴联合循经推拿疗法对脑瘫患儿运动功能的干预效果[J]. 世界中西医结合杂志，2021，16(11)：2105-2110，2114.

[5] 肖瑜康，李丹莹，李海峰. 头皮针刺联合语言康复增强脑卒中失语症的疗效[J]. 神经损伤与功能重建，2019，14(11)：581-582，592.

[6] 邱莹，张惠，朱美华，等. 浮针疗法治疗痛证的临床研究进展[J]. 中国社区医师，2023，39(15)：3-5.

[7] 李光硕，赵性泉.《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》解读[J]. 中国卒中杂志，2024，19(8)：956-961.

[8] 高素荣. 失语症[M]. 2版. 北京：北京大学医学出版社，2006：518-519.

[9] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京：南京大学出版社，2017：10.

[10] 张宇，李志清，苟志勇. 新编神经系统疾病诊疗指南[M]. 北京：中国科学技术出版社，2015：150.

[11] 中国康复医学会儿童康复专业委员会，中国残疾人康复协会小儿脑性瘫痪康复专业委员会，《中国脑性瘫痪康复指南》编委会. 中国脑性瘫痪康复指南(2015)：第七部分[J]. 中国康复医学杂志，2016，31(1)：118-128.

[12] 刘清国，胡玲. 经络腧穴学[M]. 3版. 北京：中国中医药出版社，2012.

[13] 周仲瑛. 中医内科学[M]. 7版. 北京：中国中医药出版社，2003：408.

[14] 韩刚，韩苏娟. 针灸辅助语言训练对脑卒中失语症患者语言功能及神经功能的影响[J]. 临床医学研究与实践，2024，9(32)：143-146.

[15] 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J]. 中医药临床杂志，2023，35(10)：2068-2069.

[16] 李胜利. 言语治疗学[M]. 北京：华夏出版社，2004：378.

[17] 刘炜，倪海滨，杭方杰. 针刺联合艾灸督脉组穴治疗急性缺血性卒中的临床研究[J]. 中国中医急症，2021，30(6)：991-994.

[18] 符仲华. 浮针医学纲要：基于基础医学的现代针灸[M]. 北京：人民卫生出版社，2016：10-16.

[19] 李百韬，孙晓伟，阮野，等. 浮针联合常规针刺对痰瘀阻络型颈性眩晕患者症状及功能改善的临床研究[J]. 针灸临床杂志，2023，39(4)：11-15.

[20] 林祺，罗妮莎，杨春滟，等. 再论浮针疗法对针灸学发展的启示[J]. 中国针灸，2020，40(3)：307-314.

[21] 王富春，李铁. 临床针法备要[M]. 上海：上海科学技术出版社，2021：79.

[22] 张莎莎，肖婷婷，沈凤梅，等. 针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症62例临床研究[J]. 江苏中医药，2020，52(12)：58-61.

[23] 孙定炯，张光彩，雷贝贝. 通关利窍针法联合口腔功能训练对卒中后失语症患者失语症程度及语言功能恢复的干预作用[J]. 陕西中医，2020，41(10)：1474-1477.

中国知网 https://www.cnki.net